

高齢者機能評価（GA）研究のご紹介

高齢びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫（DLBCL）の治療前評価研究

— UMIN000062924

簡易老年医学的評価（sGA）とは

簡易老年医学的評価（simplified geriatric assessment：sGA）とは、高齢者の身体機能、精神機能、認知機能、栄養状態、社会的背景などを短時間で多面的に把握するために用いられる効率的なスクリーニング手法です

本来の「包括的高齢者機能評価（CGA）」は非常に有用ですが、項目が多く多大な時間と専門知識を要します。
そのため、日常の限られた臨床現場（特に外来やがん化学療法の導入前など）で現実的に運用できるよう簡略化されたものがsGA

なぜ「高齢者機能評価」が必要か

年齢だけでは決められない

同じ 80 歳でも、ひとりで元気に暮らす方もいれば、日常生活に介助が必要な方もいます。

治療が弱すぎても強すぎても困る

治る病気なのに治療が弱いと根治を逃します。
強すぎると治療を最後まで続けられません。

生活の情報が一番の手がかり

ADL、IADL、入浴、食事、薬の管理、家族の支え、通院、経済状況などなど

治療の最適化は、今、2つの方向から進んでいます

方向① がん細胞を詳しく知る

遺伝子などの検査で、効きやすい治療が
わかってきた

「どの薬が効くか」を決める



方向② 患者さんを詳しく知る

体力・生活・持病・支援を細かくつかむ
(GA)

「どの強さなら安全に届けられるか」を決める

効く治療を、その方に合った強さで、安全に行う

3 / 研究の概要

治療の前に「生活の力」を測り、結果を見ていきます

項目	内容
対象	新しく DLBCL と診断された高齢の患者さん
治療前に測るもの	日常動作（ADL・IADL）、持病（CIRS-G）、栄養、もの忘れ、暮らしの状況
知りたいこと	治療の完遂・副作用・ADL低下をどこまで予測できるか、補強できる“弱り”は何か
3 つに分けます	fit（元気）／ unfit（少し脆弱）／ frail（脆弱）
見ていくこと	予定した治療を最後まで受けられたか、治療後に日常動作が下がらなかったか
評価の時期	治療前 ／初回コース前／治療終了時（2回目以降はカルテの記載から集めます）

sGA の項目だけでなく、他の要因も探索

広めに集めて、関係を調べる

- 栄養（体重減少、食事量、食欲、嚥下）
- お薬の管理と通院の状況
- もの忘れの気がかり
- 暮らしの状況（独居、支援者、転倒）
- 最近急に悪くなったこと

治療を最後までできたか、日常動作が下がったかと関係する要因を探り、必要十分な評価項目に絞り込みます。

この研究の新しさ

- 病気そのものによる弱りを分けて見る（前治療後に再評価）
- 時にご家族にも協力いただき普段の状態を聞く
- アプリの使用で迅速に、医師判断との適合性判断
- 質問の量は患者さんに合わせて自動で調整する

「弱り」を見つけるだけでなく、どう補えるかを見ます

補える可能性のある弱り

- 低栄養、食事量の低下
- お薬の管理が難しい
- 独居、支援が足りない
- 遠距離、冬の通院が困難
- 病気による急な ADL 低下

治療の強さを考える弱り

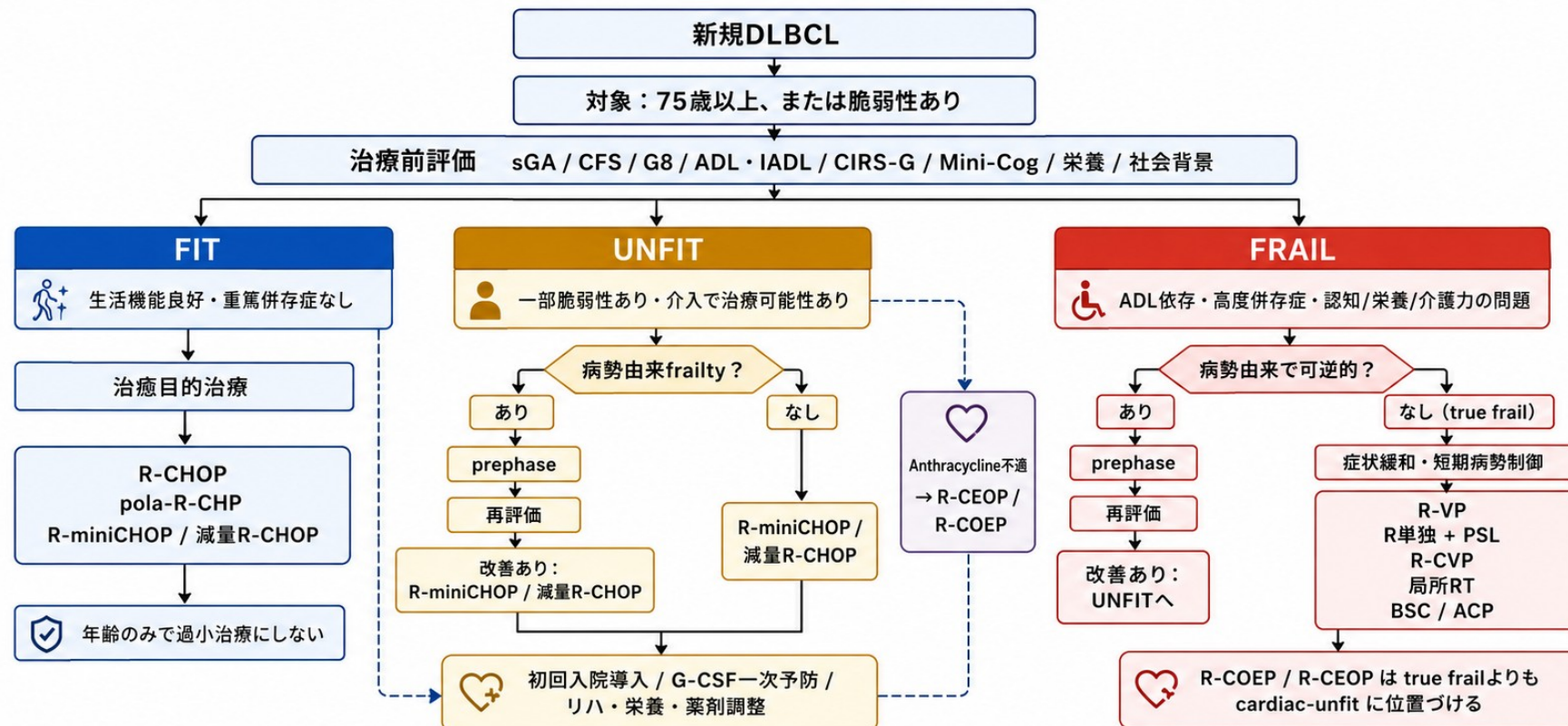
- 高齢そのもの
- 元に戻りにくい ADL 低下
- 重い心臓・肺・腎臓の病気
- 高度な認知機能の低下
- 治療の完遂が難しい併存症

多職種が連携した気づきが、補える弱りを見つける手がかりになります

評価の結果は、治療の強さを考える手がかりになります

高齢DLBCLにおける当科治療フロー(案)

目的：過小治療と過剰治療を減らし、患者ごとの最適な治療強度を考える



※ スコアは治療可否の自動判定ではなく、治癒可能性を保ちながら安全に治療するための補助線として用いる

7 / 問診アプリ

iPad の問診アプリで、ふだんの生活を聞きます

生活についての質問

読み上げる

これから、普段の生活の様子について、いくつか質問します。まず短い質問が6つあります。多くの方は、それだけで終わります。この質問は、治療を安全に行うために、生活の状況を確認するものです。結果だけで治療方針が決まるわけではありません。医師・看護師が内容を確認し、治療方針と一緒に考えます。

はじめる (ご本人)

家族が代わりに入力する

医療者と一緒に入力する

旭川赤十字病院 血液腫瘍内科

① 開始画面

大きな文字とボタン。読み上げもできます。

普段の生活の動作について

読み上げる

普段、お風呂やシャワーに、ひとりで入れますか？

手すりを使う場合も「ひとりでできる」に含みます。

① ひとりでできる

② 少し手伝いが必要

③ ほとんど、または全部手伝いが必要

② 質問画面

1画面に1問。3つから選ぶだけです。

sGA判定 (アプリ算出・Merli 2021準拠)

unfit

アプリ判定 (Merli 2021準拠) 80歳以上・4基準をすべて満たす

CIRS-G grade 3~4 の系統数 (14系統中・重度/極めて重度)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CIRS-G grade 2 の系統数 (中等度)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

項目	今回の値	基準	結果
ADL 自立項目数	6 / 6	6 (全項目自立)	✓ 満たす
IADL 自立項目数	8 / 8	8 (全項目自立)	✓ 満たす
CIRS-G grade 3~4 の系統数	0	0	✓ 満たす
CIRS-G grade 2 の系統数	3	4以下	✓ 満たす

80歳以上：4つすべて満たせば unfit、1つでも外れれば frail (単にはならない)

先生の判定 (アプリ判定を見たあとで選択・任意。もう一度押すと未選択に戻る)

fit unfit frail

③ 医療者用の画面

fit・unfit・frailの目安を表示。患者さんの画面には出ません。

高齢者の治療選択を、より公平で具体的に

今

生活機能・認知・栄養・
支援体制が見える化する

次に

何を補えば安全に治療できるか
を検討する

将来

90代でも、治療後の生活が不安
なく送れる治療選択へ

治療できる人／できない人を分ける研究ではない

二重特異性抗体や CAR-T など新しい治療でも、年齢だけで除外しないために、
受けられるか・本人にとって価値があるかを公平に見えるようにしていきたい。

現場の流れと、お願いしたいこと

- 1 担当医が研究を説明し、同意書をいただく
- 2 研究 ID （ AS-〇〇〇 ） を割り当てる
- 3 iPad で、ご本人またはご家族が問診に答える
- 4 医療者が内容を確認し、データを送信する
- 5 カルテに、治療の目標（根治か）と予定用量を記載する

看護師さんへのお願い

- 操作が難しい方の入力を、そばでお手伝いください
- 氏名やカルテ ID は入力しません。研究 ID だけです
- 評価は医療者間のみで共有ください